SDG Ziel 3	Gesundheit und Wohlergehen
SDG Unterziel 3.3	Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen
SDG Indikator 3.3.4	Hepatitis-B-Inzidenz je 100.000 Einwohner/-innen
Zeitreihe	Hepatitis-B-Inzidenz

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe
   - Stand der nationalen Metadaten: 7. Mai 2026
   - Nationale Daten: https://sdg-indikatoren.de/3-3-4
   - Definition: Die Zeitreihe stellt die Anzahl der gemeldeten Hepatitis-B-Fälle je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner dar.
   - Disaggregation: Nicht verfügbar.

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten
   - Stand der UN-Metadaten: Juli 2026
   - UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-04.pdf
   - Die Zeitreihe entspricht nicht den UN-Metadaten, bietet aber zusätzliche Informationen.

3. Beschreibung der Daten
   - Das im Januar 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt in Deutschland die Meldepflicht für bestimmte übertragbare Krankheiten. Die Meldung erfolgt in der Regel durch Ärztinnen und Ärzte sowie durch Labore und ist verpflichtend. Dennoch kann es zu Untererfassungen kommen, da nicht alle diagnostizierten meldepflichtigen Erkrankungen vollständig in das Meldesystem eingehen. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Hepatitis-B-Fälle basieren auf Meldungen gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe e IfSG.

     Bis zum Jahr 2015 orientierten sich die Falldefinitionen für Hepatitis B insbesondere an akuten Erkrankungsfällen, bei denen klinische Symptome in Verbindung mit entsprechenden laborchemischen Nachweisen vorlagen. Mit der Überarbeitung der Falldefinitionen im Jahr 2015 wurde die Erfassung stärker auf standardisierte diagnostische Kriterien ausgerichtet und die Vergleichbarkeit der Meldedaten verbessert.

     Im Jahr 2017 wurden im IfSG sowie in den Melde- und Übermittlungsverfahren verschiedene Anpassungen vorgenommen. Diese dienten vor allem der Weiterentwicklung der Surveillance-Strukturen sowie der Verbesserung der Vollständigkeit, Qualität und Vergleichbarkeit der erhobenen Daten im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsberichterstattung.

Weitere Anpassungen der Falldefinitionen erfolgten im Jahr 2019. Diese dienten insbesondere der Aktualisierung diagnostischer Standards sowie der weiteren Harmonisierung der epidemiologischen Bewertung meldepflichtiger Erkrankungen.

Die Bevölkerungsdaten stammen aus der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes. Für die Berechnung wird die zurückgerechnete Durchschnittsbevölkerung verwendet. Für das Jahr 2010 basiert sie auf dem Zensus 2011 sowie den Wanderungs-, Geburten- und Sterbestatistiken; für die Jahre 2012 bis 2021 erfolgte die Berechnung entsprechend auf Grundlage des Zensus 2022.

4. Link zur Datenquelle
   - Online Datenbank SurvStat@RKI 2.0: https://survstat.rki.de/
   - Infektionsepidemiologisches Jahrbuch: https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Infektionsepidemiologisches-Jahrbuch/infektionsepidemiologisches-jahrbuch-node.html
   - Durchschnittliche Bevölkerung – GENESIS online 12411-0041: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0041
   - Rückgerechnete und fortgeschriebene Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html#sprg233540

5. Metadaten zur Datenquelle
   - Online-Datenbank SurvStat@RKI 2.0 - Inhaltliche Hinweise: https://survstat.rki.de/Content/Instruction/Content.aspx
   - Qualitätsbericht – Mikrozensus: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/einfuehrung.html

6. Aktualität und Periodizität
   - Aktualität: t + 3 Wochen nach Datenerhalt
   - Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode
   - Maßeinheit: Je 100 000 Einwohner/-innen
   - Berechnung: Nicht zutreffend.